# Troubles des conduites alimentaires

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

**Abréviations** : TCA = troubles du comportement alimentaire · DSM-5-TR = classification américaine des troubles mentaux · AM = anorexie mentale · HB = hyperphagie boulimique · ARFID = trouble restrictif / évitant de l'alimentation · TCC = thérapie cognitivo-comportementale · SRI = syndrome de renutrition inappropriée · ADH = alcool déshydrogénase · ALDH = aldéhyde déshydrogénase · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

**Réflexes d'examen** : verre standard = **10 g d'alcool** · g = V (mL) × degré / 100 × 0,8 · repères : **≤ 10 verres/semaine, ≤ 2/jour, pas tous les jours**, **zéro pendant la grossesse** · **thiamine avant le glucose** chez l'alcoolique dénutri · SCOFF-F = **repérage** (≥ 2/5) · AM : **aménorrhée n'est plus un critère** · vomissements → **alcalose** · HB : **pas de compensation**, pas de régime strict · diététique des TCA : **3 repas + collations, ne rien interdire**.

## 1. Cadre général (40.3)

- **TCA** = perturbation persistante de l'alimentation qui altère la santé ou la vie sociale · DSM-5-TR : **anorexie mentale**, **boulimie**, **hyperphagie boulimique**, **ARFID**, pica, mérycisme, autres TCA.
- Fréquence (vie entière) : HB = TCA **le plus fréquent**, puis boulimie, puis AM · nettement plus fréquents chez les femmes · AM : début vers 14-17 ans, mortalité élevée ; environ la moitié guérit.
- **SCOFF-F** : 5 questions, ≥ 2 réponses positives → évaluation spécialisée (outil de **repérage**, pas de diagnostic).
- **ARFID** : restriction **sans** peur de grossir (dégoût sensoriel, peur de s'étouffer, manque d'intérêt).
- **Trouble de l'usage** d'une substance : 11 critères sur 12 mois · léger (2-3), modéré (4-5), sévère (≥ 6).

## 2. L'alcool (40.3.1)

- Masse d'alcool (g) = volume (mL) × degré / 100 × **0,8** · **7 kcal/g** (calories « vides »).
- Alcoolémie (Widmark) = g d'alcool / (poids × **0,7** chez l'homme ou **0,6** chez la femme) · élimination ≈ 0,10-0,15 g/L/h · questionnaire **AUDIT** pour repérer le mésusage.
- Métabolisme : **ADH** (cytosol), **MEOS-CYP2E1** (inductible), catalase → **acétaldéhyde** (toxique) → **ALDH2** → acétate · excès de **NADH** → hypoglycémie, lactate et acide urique ↑, **stéatose**.
- Conséquences nutritionnelles : apports alimentaires réduits, malabsorption, carences (**B1**, folates, B6, zinc, magnésium), fonte musculaire.

## 3. Thiamine et Gayet-Wernicke (40.3.1)

- Thiamine (B1) → coenzyme **TPP** du métabolisme du glucose (pyruvate déshydrogénase, α-cétoglutarate déshydrogénase, transcétolase) · **réserves faibles** (quelques

semaines).
- **Encéphalopathie de Gayet-Wernicke** : confusion, troubles de l'équilibre, troubles des mouvements des yeux · triade complète dans **moins d'1 cas sur 5 → traiter au moindre doute** · séquelle possible : syndrome de **Korsakoff** (amnésie).
- **Thiamine avant (ou avec) le glucose** : le glucose sans B1 peut déclencher l'encéphalopathie · prévention systématique au sevrage.
- Nutrition de l'alcoolique : repérer la dénutrition, prévenir le **SRI** (renutrition progressive, phosphore, potassium, magnésium), supplément vitaminique, alimentation équilibrée, accompagnement du sevrage.

## 4. Tabac, cannabis et autres substances (40.3.1)

- Tabac : dépendance mesurée par le test de **Fagerström** (0-10 ; forte à partir de 7) · paquets-années = (cigarettes par jour / 20) × années · arrêt = prise de poids moyenne de quelques kilos → conseils pour la limiter, sans régime strict.
- Cannabis : récepteurs **CB1** → fringales · usage prolongé : syndrome d'hyperémèse (vomissements cycliques, soulagés par les douches chaudes ; traitement = arrêt).

## 5. Anorexie mentale (40.3.2)

- Critères : **restriction** → poids significativement bas · **peur intense de grossir** · **perception altérée** du corps · types **restrictif** ou avec **crises et purges** · gravité chez l'adulte selon l'IMC (léger ≥ 17 → extrême < 15).
- Adaptations : **leptine ↓** → axe gonadotrope freiné (**aménorrhée**, fréquente mais **plus un critère**) · **T3 basse** (économie d'énergie, ne se traite pas par hormones) · cortisol ↑ · IGF-1 ↓ · **ghréline ↑** (la faim existe, mais elle est niée).
- Complications : **bradycardie**, troubles du rythme, hypotension, hypothermie, **hypoglycémie**, baisse des globules blancs, **ostéoporose**.
- Hospitalisation (HAS 2010) : selon des critères de gravité somatiques (IMC très bas, perte de poids rapide, pouls ou pression très bas, hypothermie, troubles ioniques) et psychiques.
- **Renutrition** : progressive, reprise de poids visée ≈ 0,5-1 kg/semaine à l'hôpital, 0,2-0,5 kg en ambulatoire · prévenir le **SRI** (phosphore, potassium, magnésium, thiamine ; voir chapitre 41) · **repas thérapeutique** accompagné · prise en charge **pluridisciplinaire** (psychiatre, médecin, diététicien, famille).

## 6. Boulimie (40.3.3)

- Crises (grande quantité, **perte de contrôle**) + **comportements compensatoires** (vomissements, laxatifs, jeûne, sport excessif), au moins 1 fois/semaine pendant 3 mois · poids souvent **normal** · gravité selon le nombre de compensations par semaine.
- Conséquences : vomissements → perte d'acide → **alcalose hypochlorémique** et **hypokaliémie** (risque cardiaque) · laxatifs → **acidose**, pertes d'eau et d'électrolytes (sans empêcher l'absorption des calories) · atteinte des dents, des glandes salivaires, de l'œsophage.
- Traitement : **TCC** (thérapie de référence) · parfois un antidépresseur · suivi diététique.

## 7. Hyperphagie boulimique (40.3.4)

- Crises ≥ 1 fois/semaine pendant 3 mois, avec **détresse** et au moins 3 caractéristiques (manger vite, jusqu'à l'inconfort, sans faim, seul par honte, culpabilité) · **sans compensation** régulière.
- Fréquente chez les personnes obèses qui consultent (20-30 %).
- Traitement : **TCC** · **pas de régime restrictif** (la restriction entretient les crises) · **d'abord les crises, ensuite le poids** (perte modérée de 5-10 %).

## 8. Diététique commune aux TCA

- **Structure** : 3 repas + 1 à 3 collations, horaires réguliers.
- **Ne rien interdire** · réintroduire progressivement les aliments redoutés · travailler les sensations de faim et de satiété.
- Outils : **carnet alimentaire** (boulimie, HB) · **repas thérapeutique** (AM) · posture bienveillante, sans jugement · travail en équipe.

## Pièges

- Aménorrhée **retirée** des critères de l'AM (DSM-5) · dans l'AM la faim **existe** · leptine **effondrée** · T3 basse = adaptation, **pas de traitement hormonal**.
- HB = **sans** vomissements réguliers · ARFID = **sans** peur de grossir · SCOFF-F = repérage.
- Vomissements → **alcalose** · laxatifs n'empêchent pas l'absorption des calories.
- Repère alcool : **2 verres/jour pour tous** · grossesse : **zéro**.
- Thiamine **avant** le glucose · triade de Wernicke souvent **incomplète** · Fagerström 3 = dépendance **faible**.